

Cel leczenia

Czy musisz całkowicie przestać pić — czy wystarczy ograniczyć? Odpowiedź zależy od tego, na jakim etapie spektrum AUD się znajdujesz.

CZAS: 15 min 1 sesja decyzyjna

ŹRÓDŁO: Sobell & Sobell (1993, 2000); NICE CG115 (2011); Witkiewitz (2017)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **kryteria TAK/NIE** dla kontrolowanego picia (sekcja 01). Odpowiedz szczerze na każde pytanie. Jeśli choć **jedno** czerwone kryterium dotyczy Cię — kontrolowane picie nie jest dla Ciebie bezpieczne. Następnie zapoznaj się z zasadami obu dróg (sekcja 02–03) i wybierz cel w polu na końcu. *Cel może ewoluować* w trakcie terapii.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Tradycyjne podejście (np. AA) zakłada, że jedynym celem leczenia jest abstynencja. *Sobell & Sobell* (1973, 1993) udowodnili, że **w łagodnym AUD bez powikłań** kontrolowane picie jest osiągalne. *NICE CG115* (2011) i *WHO* (2010) zalecają, by **pacjent sam wybierał cel** — abstynencję lub redukcję. Powód: pacjent niegotowy na abstynencję, który *nie dostaje żadnego leczenia*, ryzykuje najwięcej. Redukcja jako most do abstynencji ratuje więcej osób niż dychotomia „wszystko albo nic”.

01 ? Czy mogę próbować kontrolowanego picia?

✓ KRYTERIA TAK

- AUDIT ≤ 19 (picie ryzykowne lub szkodliwe, ale nie ciężkie uzależnienie)
- **Brak** drgawek lub *delirium tremens* w historii
- **Brak** marskości lub poważnego uszkodzenia wątroby
- Stabilne zdrowie psychiczne (brak psychozy aktywnej)
- **Nie jestem** w ciąży ani nie planuję jej w najbliższym czasie
- Nie miałem/-am więcej niż 2 nieudane próby kontroli picia

✗ KRYTERIA NIE

- AUDIT ≥ 20 (prawdopodobne uzależnienie)
- Historia drgawek alkoholowych lub *DT*
- Marskość, zaawansowane stłuszczenie, hepatitis
- Ciąża lub karmienie piersią — **tylko abstynencja**
- Współistniejąca psychoza, ciężka depresja z myślami samobójczymi
- Powtarzające się nieudane próby kontroli (≥ 3)

Jeśli choć **jedno** kryterium z prawej kolumny dotyczy Cię — kontrolowane picie nie jest bezpieczną opcją. Rozważ abstynencję od początku, najlepiej z konsultacją medyczną przy zależności fizycznej.

02 📅 Kontrolowane picie — zasady, jeśli idziesz tą drogą

LIMIT DZIENNY

Maks. **2 drinki/dzień** dla M, **1 drink/dzień** dla K. Sztywno. Nie „średnio”.

DNI BEZ ALKOHOLU

Minimum **3 dni** w tygodniu — zaplanowane, zaznaczone w kalendarzu.

DZIENNIK

Codzienny zapis — ile, kiedy, kontekst. Bez dziennika kontrolowane picie się nie udaje.

MONITOROWANIE AUDIT

Co **3 miesiące** powtarzaj AUDIT. Wynik musi spadać. Jeśli nie spada — wracamy do rozmowy o abstynencji.

KONTEKST

Wyłącznie do **posiłku** lub planowanej sytuacji towarzyskiej. Nie sam/-a, nie wieczorem przed snem.

PLAN B

Jeśli przekraczam limit przez 2 tygodnie z rzędu — natychmiast wracam do terapeuty. To **sygnał**, nie porażka.

03 © Abstynencja — kiedy jest jedynym sensownym celem

Abstynencja od alkoholu nie jest wyborem ideologicznym ani moralnym. Jest **decyzją medyczną** wynikającą z tego, jak działa Twój mózg po latach picia. Pięć sytuacji, w których ciężko o inną drogę.

1 • CIĘŻKIE AUD

AUDIT ≥ 20 , ≥ 6 kryteriów DSM-5. Mózg ma trwałe zmiany w układzie nagrody — jeden drink reaktywuje cały dawny wzorzec (*efekt prymowania*).

2 • ZALEŻNOŚĆ FIZYCZNA

Drżenia, poty, niepokój po przzerwaniu — to nie „nerwy”, to neurochemia. Odstawienie wymaga konsultacji medycznej (ryzyko drgawek).

3 • USZKODZENIE WĄTROBY

Marskość, hepatitis alkoholowy, podwyższone enzymy — wątroba potrzebuje czasu i całkowitej przerwy.

4 • CIĄŻA

Nie istnieje **bezpieczna dawka** alkoholu w ciąży. Każda ilość ryzykuje FAS (*ang. Fetal Alcohol Syndrome, alkoholowy zespół płodowy*).

5 • POWTÓRNE NIEUDANE PRÓBY KONTROLI

Jeśli ≥ 3 razy próbowałeś/-aś ograniczyć i nie udawało się — to nie jest kwestia silnej woli. To informacja o tym, że Twój mózg potrzebuje **całkowitej** przerwy, by się przeorganizować.

04 ✎ Mój cel — na najbliższe 3 miesiące

WYBIERAM

— abstynencja całkowita / redukcja do limitu / inny cel

CO SKŁANIA MNIE DO TEGO WYBORU

DATA EWALUACJI

— kiedy sprawdzę, czy idzie

Klucz: Pacjent, który odrzuca abstynencję i *nie dostaje żadnego leczenia*, to najgorszy możliwy scenariusz. Pacjent, który zaczyna od redukcji jako mostu do zmiany — jest już w drodze. Witkiewicz i wsp. (2017): ~50% osób w łagodnym AUD utrzymuje kontrolowane picie przez ≥ 3 lata; pozostali przesuwają się ku abstynencji. **Cel może ewoluować** — to nie jest ostateczna deklaracja, tylko pierwszy krok.